Algoritmo CIF — Tobillo y Pie

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Tobillo y pie. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

2 ¿Algún criterio de Ottawa de tobillo o de pie, Thompson positivo, o mecanismo de Lisfranc o de caída sobre el talón? → DERIVAR para radiografía (Ottawa) o derivación preferente (Aquiles, Lisfranc, calcáneo) antes de seguir explorando.

SÍ

- OTTAWA DE TOBILLO POSITIVO → 37 Fractura de Tobillo (Maleolar)
- OTTAWA DE PIE POSITIVO → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- THOMPSON POSITIVO → 3 Rotura del Aquiles
- MECANISMO DE LISFRANC → 4 Lesión de Lisfranc
- CAÍDA SOBRE EL TALÓN → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- NINGUNO → sin hipótesis

3 Tobillo agudo traumático, ¿qué mecanismo cuenta?

- ESGUINCE LATERAL → 1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)
- SINDESMOSIS → 2 Lesión de la Sindesmosis
- CALCANEOCUBOIDEA → 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana
- LUXACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR → 6 Luxación del Tibial Posterior
- NINGUNO → sin hipótesis

1 ¿Traumatismo agudo?

- **SÍ** — Traumatismo agudo: Ottawa primero, después por mecanismo → → desvío 2
- **NO** — Sin traumatismo: por edad y localización → sin hipótesis

NO

4 ¿Niño o adolescente con dolor bien localizado o sin mecanismo claro?

- **SEVER** — Inserción del Aquiles (8–12 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **ISELIN** — Base del 5.º MT (8–13 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **APOFISITIS DEL TIBIAL POSTERIOR o KÖHLER** — Navicular (menores de 10, cojera) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **FREIBERG** — Cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** — Esguince que no se resuelve, bloqueo → 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo
- **OSTEOMA OSTEOIDE** — Dolor nocturno con alivio rápido por AINE: derivar → sin hipótesis
- **NO** — Adulto, o hay mecanismo claro → sin hipótesis

todas

5 ¿La exploración local no reproduce el dolor conocido? → COLUMNA LUMBAR u origen proximal: slump con flexión plantar e inversión. Si persiste la duda, replantear (malignidad).

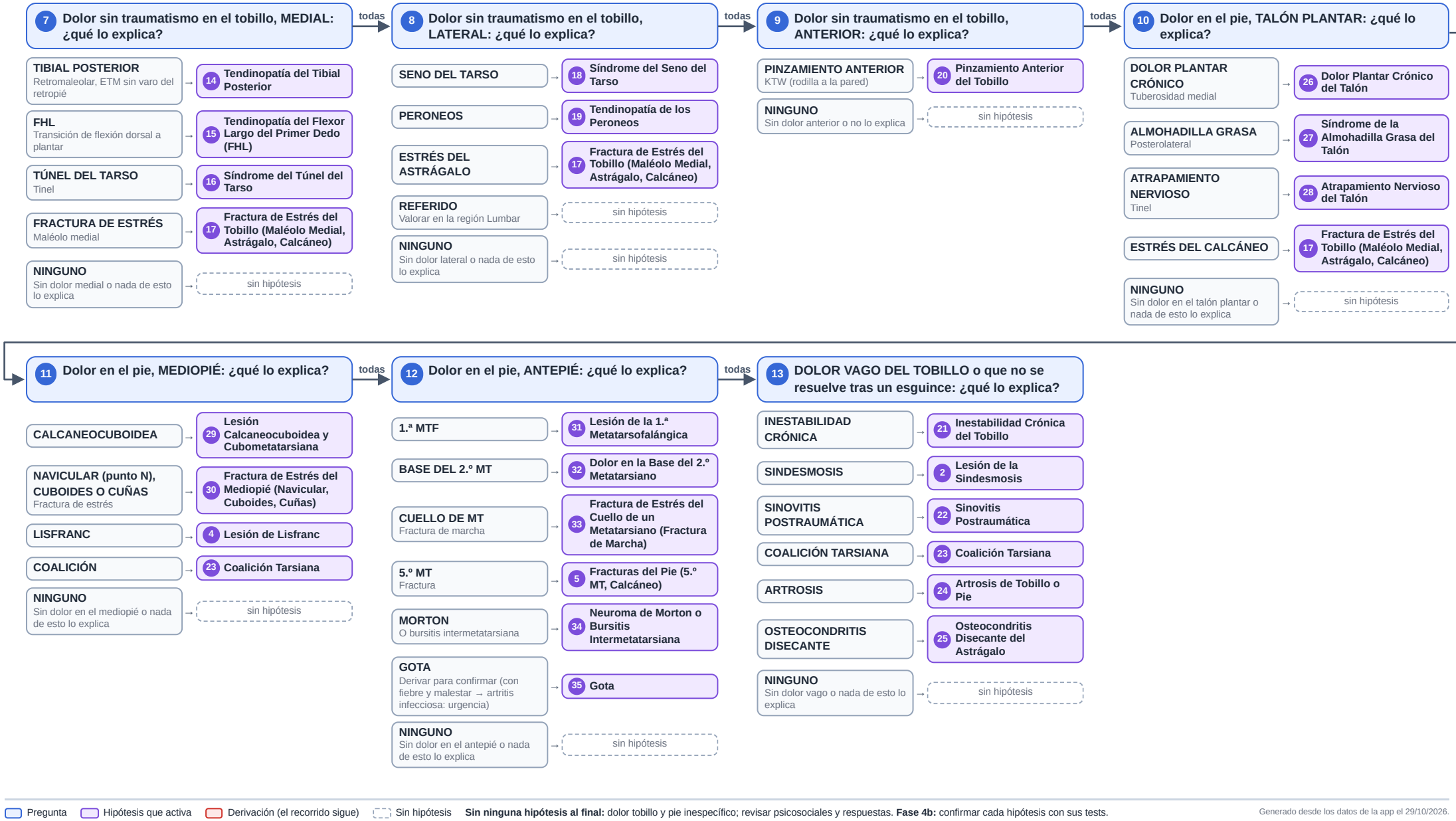
- **COLUMNA LUMBAR u origen proximal** — El slump con flexión plantar e inversión reproduce: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO REPRODUCE NADA** — Persiste la duda: replantear (malignidad) → sin hipótesis
- **NO** — La exploración local sí reproduce el dolor conocido → sin hipótesis

todas

6 Dolor sin traumatismo en el tobillo, POSTERIOR: ¿qué lo explica?

- **PINZAMIENTO POSTERIOR** — Flexión plantar máxima → 7 Pinzamiento Posterior del Tobillo
- **AQUILES PORCIÓN MEDIA** — Pinza, 2–6 cm → 8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media
- **AQUILES INSERCIONAL** — Un dedo, flexión dorsal → 9 Tendinopatía Insercional del Aquiles
- **VAINA DEL AQUILES** — Crepitación, rango amplio → 10 Afectación de la Vaina del Aquiles
- **PLANTAR DELGADO** — Medial y proximal → 11 Tendinopatía del Plantar Delgado
- **NERVIO SURAL** — Lateral, neuropático → 12 Neuropatía del Nervio Sural
- **BURSA SUPERFICIAL** — Roce del zapato → 13 Bursitis Calcánea Superficial
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →



Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor tobillo y pie inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.